PBM-EVAL · CUESTIONARIO · 200 preguntas · Serie PBM · evaluación formativa

Cuestionario de evaluación — Serie PBM

200 preguntas tipo test sobre Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria — con soluciones razonadas

2026 · Preguntas fundamentadas en los 23 documentos y verificadas contra PubMed · CAUSA / SACYL

Uso: responde el examen (parte 1) y comprueba en las soluciones (parte 2) la respuesta correcta, la explicación y la fuente (PMID).

Cuestionario derivado de la serie formativa PBM. Cada pregunta indica el documento de origen y su nivel (Básico / Avanzado). Las soluciones incluyen explicación breve y referencia indexada. Material docente; no sustituye al juicio clínico ni a los protocolos locales vigentes.

1. Examen (200 preguntas)

PBM-01

Q001 · PBM-01 BASICO

1. ¿Cuál es el cambio de paradigma central del Patient Blood Management (PBM)?

A Centrarse en el paciente y preservar su propia sangre

B Centrarse en el producto (la bolsa de sangre)

C Transfundir siempre de forma liberal

D Eliminar toda transfusión

Q002 · PBM-01 BASICO

2. ¿Cuáles son los 3 pilares del PBM?

A Optimizar masa eritrocitaria, minimizar pérdida y tolerar la anemia

B Cristaloides, coloides y hemoderivados

C Diagnóstico, tratamiento y seguimiento

D Prevención, cribado y rehabilitación

Q003 · PBM-01 BASICO

3. En el metaanálisis de Althoff, un programa PBM multimodal se asoció a una reducción de la tasa de transfusión de aproximadamente:

A 10%

B 25%

C 60%

D 39%

Q004 · PBM-01 AVANZADO

4. Sobre la evidencia de los programas PBM, ¿qué afirmación es la más correcta?

A Toda procede de ECA con desenlaces duros

B No hay ninguna evidencia de beneficio

C Solo aplica a cirugía cardíaca

D La reducción de transfusión es robusta; mortalidad/complicaciones, de menor certeza

Q005 · PBM-01 BASICO

5. ¿Qué consenso internacional es referencia vertebral del PBM?

A Consenso de Frankfurt 2018 (JAMA 2019)

B Declaración de Helsinki

C Consenso de Sevilla 1997

D Iniciativa Choosing Wisely

Q006 · PBM-01 BASICO

6. Además de los 3 pilares, la serie añade un eje transversal centrado en:

A La nutrición perioperatoria

B La analgesia multimodal

C La profilaxis antibiótica

D La hemostasia y el manejo del sangrado/coagulopatías

Q007 · PBM-01 AVANZADO

7. En el metaanálisis de Althoff, la mortalidad con programa PBM mostró:

A RR 1,50 (aumento)

B RR 0,89 (reducción, certeza moderada)

C Sin estimación posible

D RR 0,10

Q008 · PBM-01 BASICO

8. El PBM es fundamentalmente:

A Una técnica quirúrgica

B Una estrategia multimodal y multidisciplinar

C Un fármaco

D Un tipo de hemoderivado

Q009 · PBM-01 BASICO

9. En el PBM, la transfusión se considera:

A El objetivo terapéutico principal

B Siempre contraindicada

C Indicada por debajo de Hb 10 g/dl siempre

D Una herramienta más, reservada para cuando aporta beneficio

PBM-02

Q010 · PBM-02 BASICO

10. ¿Qué aporta principalmente el concentrado de hematíes?

A Factores de coagulación

B Plaquetas

C Fibrinógeno

D Transporte de oxígeno

Q011 · PBM-02 BASICO

11. Umbral restrictivo de hematíes en el adulto estable hospitalizado (AABB 2023):

A Hb < 7 g/dl

B Hb < 10 g/dl

C Hb < 9 g/dl

D Hb < 5 g/dl

Q012 · PBM-02 BASICO

12. En cirugía cardíaca, el umbral de hematíes admitido por la AABB es:

A Hb < 6 g/dl

B Hb < 7,5 g/dl

C Hb < 9 g/dl

D Hb < 11 g/dl

Q013 · PBM-02 BASICO

13. Una unidad de hematíes eleva la Hb en el adulto aproximadamente:

A 0,1 g/dl

B 3 g/dl

C 1 g/dl

D 5 g/dl

Q014 · PBM-02 BASICO

14. Umbral profiláctico de plaquetas en trombocitopenia hipoproliferativa (AABB/ICTMG 2025):

A < 30 ×10⁹/l

B < 50 ×10⁹/l

C < 10 ×10⁹/l

D < 100 ×10⁹/l

Q015 · PBM-02 AVANZADO

15. Según la guía de plaquetas 2025, antes de una punción lumbar se sugiere transfundir si plaquetas:

A < 20 ×10⁹/l

B < 50 ×10⁹/l

C < 10 ×10⁹/l

D No transfundir nunca

Q016 · PBM-02 AVANZADO

16. En hemorragia intracraneal no quirúrgica con plaquetas > 100 ×10⁹/l, incluso bajo antiagregantes, la guía 2025:

A Recomienda transfundir plaquetas

B Recomienda plasma

C Recomienda fibrinógeno

D Recomienda NO transfundir plaquetas

Q017 · PBM-02 BASICO

17. El plasma fresco congelado está indicado, esencialmente, en:

A Cualquier INR alterado sin sangrado

B Como expansor de volumen

C Para revertir warfarina siempre

D Sangrado/procedimiento invasivo con coagulopatía documentada

Q018 · PBM-02 BASICO

18. El dintel de reposición de fibrinógeno en sangrado (ESAIC) es:

A < 1,5 g/l

B < 0,5 g/l

C < 3 g/l

D < 5 g/l

Q019 · PBM-02 AVANZADO

19. En cirugía cardiovascular sin sangrado mayor ni trombocitopenia, la guía 2025 sobre plaquetas:

A Recomienda profilaxis sistemática

B Exige 2 unidades de aféresis

C Recomienda crioprecipitado

D Recomienda NO transfundir profilácticamente

Q020 · PBM-02 BASICO

20. El error más frecuente de uso inapropiado de componentes es:

A Calentar la sangre

B Usar filtros de leucorreducción

C Transfundir por una analítica en un paciente que no sangra

D Transfundir de unidad en unidad

PBM-03

Q021 · PBM-03 BASICO

21. Hoy, el riesgo transfusional más grave y evitable es:

A El error de identificación (transfusión ABO incompatible)

B La transmisión de VIH

C La hipotermia

D La hipocalcemia

Q022 · PBM-03 BASICO

22. ¿Cuál es la última barrera y la más eficaz contra la transfusión equivocada?

A El cribado del donante

B Las pruebas cruzadas

C La comprobación final de identidad a pie de cama

D La irradiación del componente

Q023 · PBM-03 BASICO

23. El TACO corresponde a:

A Sobrecarga circulatoria asociada a transfusión

B Lesión pulmonar inmunomediada

C Reacción febril no hemolítica

D Contaminación bacteriana

Q024 · PBM-03 AVANZADO

24. Diferencia clave entre TACO y TRALI:

A TACO es inmunomediada y TRALI hidrostática

B TACO es hidrostática (volumen) y TRALI es lesión pulmonar inmunomediada

C Ambas son infecciosas

D Ninguna causa disnea

Q025 · PBM-03 BASICO

25. Ante una reacción transfusional grave, la primera medida es:

A Acelerar la transfusión

B Administrar más volumen

C Detener la transfusión y mantener la vía

D Dar un diurético siempre

Q026 · PBM-03 AVANZADO

26. La enfermedad injerto contra huésped asociada a transfusión (TA-GVHD) se previene con:

A Lavado de hematíes

B Calentamiento

C Filtros de microagregados

D Irradiación de componentes en pacientes de riesgo

Q027 · PBM-03 BASICO

27. La trazabilidad bidireccional de cada unidad es:

A Una exigencia legal en la UE

B Opcional

C Solo para plaquetas

D Innecesaria con leucorreducción

Q028 · PBM-03 BASICO

28. Ante disnea durante una transfusión, lo más frecuente e infradiagnosticado es:

A TRALI

B Anafilaxia

C TACO

D Reacción hemolítica

Q029 · PBM-03 AVANZADO

29. La medida preventiva más simple frente al TACO es:

A Transfundir rápido

B Premedicar con antihistamínico

C Transfundir despacio y de unidad en unidad

D Usar plasma siempre

PBM-04

Q030 · PBM-04 BASICO

30. La causa más frecuente y tratable de anemia preoperatoria es:

A Déficit de B12

B Hemólisis

C Aplasia medular

D Ferropenia

Q031 · PBM-04 BASICO

31. Umbral diagnóstico de anemia (criterio operativo) en la mujer:

A Hb < 120 g/l

B Hb < 100 g/l

C Hb < 130 g/l

D Hb < 140 g/l

Q032 · PBM-04 BASICO

32. ¿Cuándo debe activarse el cribado de anemia preoperatoria?

A El día de la cirugía

B En el preoperatorio inmediato

C Tras la cirugía

D Al indicar la cirugía, con antelación de semanas

Q033 · PBM-04 AVANZADO

33. ¿Por qué la ferritina puede enmascarar una ferropenia?

A Es un marcador renal

B Es un reactante de fase aguda que sube con la inflamación

C Disminuye con la edad

D Depende del grupo sanguíneo

Q034 · PBM-04 AVANZADO

34. En contexto inflamatorio, una ferropenia puede seguir siendo compatible con ferritina hasta:

A ≈ 15 µg/l

B ≈ 300 µg/l

C ≈ 100 µg/l

D ≈ 500 µg/l

Q035 · PBM-04 BASICO

35. El tratamiento de la anemia preoperatoria crónica NO es:

A Tratar la causa (hierro, etc.)

B La EPO en casos seleccionados

C La transfusión el día de la cirugía

D El cribado precoz

Q036 · PBM-04 BASICO

36. Una ferritina < 30 µg/l indica:

A Sobrecarga de hierro

B Anemia hemolítica

C Ferropenia absoluta casi segura

D Normalidad

Q037 · PBM-04 AVANZADO

37. La saturación de transferrina baja ayuda a detectar especialmente:

A Hemocromatosis

B Talasemia

C Déficit de folato

D Ferropenia funcional

Q038 · PBM-04 BASICO

38. La anemia preoperatoria se asocia de forma consistente a:

A Menos complicaciones

B Mejor pronóstico

C Ningún efecto

D Más transfusiones, complicaciones y estancia

PBM-05

Q039 · PBM-05 BASICO

39. La pauta moderna de hierro oral que mejora absorción y tolerancia es:

A Tres tomas diarias altas

B Dosis baja una vez al día o en días alternos

C Dosis máxima nocturna

D Siempre intravenoso

Q040 · PBM-05 BASICO

40. El hierro intravenoso es preferente cuando:

A Hay semanas de margen y buena tolerancia

B La ferritina es alta

C Hay intolerancia oral, malabsorción o poco tiempo

D No hay anemia

Q041 · PBM-05 AVANZADO

41. El ensayo PREVENTT demostró que el hierro IV preoperatorio en cirugía abdominal mayor:

A Redujo a la mitad las transfusiones

B NO redujo el combinado muerte o transfusión (RR 1,03)

C Aumentó la mortalidad

D Eliminó la anemia en 24 h

Q042 · PBM-05 AVANZADO

42. La lectura correcta de PREVENTT es:

A El hierro nunca sirve

B Hay que transfundir más

C El hierro oral es peligroso

D Darlo a todo anémico, tarde y sin filiar el déficit, no rinde

Q043 · PBM-05 BASICO

43. La ferropenia funcional se caracteriza por:

A Depósitos agotados con ferritina muy baja

B Exceso de hierro

C Incapacidad de movilizar hierro pese a depósitos aparentes, típica de inflamación

D Déficit de B12

Q044 · PBM-05 BASICO

44. La dosis de carboximaltosa férrica usada en PREVENTT fue:

A 100 mg

B 500 mg

C 1000 mg

D 5000 mg

Q045 · PBM-05 AVANZADO

45. En ferropenia funcional/inflamatoria que responde mal al hierro, una opción es:

A Aumentar hierro oral

B Plasma

C Hierro IV ± EPO

D Plaquetas

Q046 · PBM-05 BASICO

46. El hierro oral requiere para reponer depósitos:

A Horas

B Días

C Semanas

D Meses fijos

PBM-06

Q047 · PBM-06 BASICO

47. Para ser eficaces, los ESA (EPO) deben administrarse:

A Solos
B Con plasma
C Con hierro suficiente
D Tras la cirugía

Q048 · PBM-06 BASICO

48. La pauta con mejor respaldo de ESA + hierro se inicia:

A 3-4 semanas antes de la cirugía
B El día de la cirugía
C Solo intraoperatorio
D Al alta

Q049 · PBM-06 AVANZADO

49. El principal riesgo de los ESA es:

A Hipotensión
B Hipoglucemia
C Sordera
D Tromboembolismo

Q050 · PBM-06 BASICO

50. Una indicación con buena relación beneficio-riesgo de la EPO es:

A Cirugía menor sin sangrado
B Paciente sin anemia
C Paciente que rechaza la transfusión
D Profilaxis universal

Q051 · PBM-06 AVANZADO

51. En qué contexto debe sopesarse con especial cuidado la EPO:

A Cirugía ortopédica
B Cirugía oncológica
C Cirugía menor
D Endoscopia

Q052 · PBM-06 AVANZADO

52. El beneficio de los ESA se concreta sobre todo en:

A Reducción de mortalidad
B Curación de la enfermedad de base
C Reducción de infecciones
D Reducción de transfusión

Q053 · PBM-06 BASICO

53. La EPO frente al hierro es:

A Su sustituto
B Equivalente
C Más barata
D Un complemento selectivo

Q054 · PBM-06 AVANZADO

54. ¿Qué guía respalda el uso de hierro y ESA en optimización preoperatoria en cirugía cardíaca?

A CRASH-2
B TRICC
C PROPPR
D EACTS/EACTAIC 2024

PBM-07

Q055 · PBM-07 BASICO

55. El modelo moderno de la hemostasia es:

A Una cascada aislada en un tubo
B Un proceso celular sobre superficies
C Solo plaquetario
D Independiente de la trombina

Q056 · PBM-07 BASICO

56. El primer factor que cae en la hemorragia masiva es:

A Factor VIII
B Factor XIII
C Protrombina
D Fibrinógeno

Q057 · PBM-07 BASICO

57. La 'tríada letal' de la coagulopatía es:

A Anemia, dolor, fiebre
B Hipoxia, hipercapnia, hipertensión
C Hipotermia, acidosis y coagulopatía
D Hipocalcemia, hipoglucemia, hipopotasemia

Q058 · PBM-07 AVANZADO

58. ¿Qué ion (factor IV) es imprescindible y se consume/quela en la transfusión masiva?

A Potasio
B Sodio
C Magnesio
D Calcio iónico

Q059 · PBM-07 BASICO

59. La minimización del sangrado en el pilar 2 se logra mediante:

A Una sola medida potente

B Solo transfusión

C Una estrategia multimodal

D Solo hemostasia quirúrgica

Q060 · PBM-07 AVANZADO

60. Antes de pedir más hemoderivados ante un sangrado que 'no para', conviene comprobar lo barato:

A Temperatura, pH y calcio iónico

B Grupo sanguíneo

C Hemoglobina glicada

D Función tiroidea

Q061 · PBM-07 AVANZADO

61. La hiperfibrinólisis perioperatoria justifica el uso de:

A Heparina

B Warfarina

C Aspirina

D Antifibrinolíticos (tranexámico)

Q062 · PBM-07 BASICO

62. Distinguir sangrado quirúrgico de coagulopático importa porque:

A El primero requiere control mecánico y el segundo corrección hemostática

B Es lo mismo

C Solo cambia la dosis de fluidos

D No cambia el manejo

PBM-08

Q063 · PBM-08 BASICO

63. El ácido tranexámico actúa:

A Activando plaquetas

B Aportando factores

C Inhibiendo la fibrinólisis (bloquea plasminógeno-fibrina)

D Quelando calcio

Q064 · PBM-08 BASICO

64. En CRASH-2, el TXA redujo la mortalidad por cualquier causa con un RR de:

A 0,91

B 0,50

C 1,10

D 1,47

Q065 · PBM-08 BÁSICO

65. El factor común de eficacia del TXA en todos los escenarios es:

A La administración precoz

B La dosis alta

C La vía intramuscular

D Asociarlo a plasma

Q066 · PBM-08 BÁSICO

66. La pauta de TXA en trauma (CRASH-2) fue:

A 1 g único IM

B 1 g en 10 min + 1 g en 8 h

C 500 mg oral

D 5 g en bolo

Q067 · PBM-08 AVANZADO

67. En WOMAN, el TXA redujo la muerte por hemorragia (RR 0,81) sobre todo cuando se administró:

A Tras 24 h

B Solo por vía oral

C En las 3 h siguientes al parto

D A dosis doble

Q068 · PBM-08 AVANZADO

68. En WOMAN, el TXA NO redujo:

A La muerte por hemorragia

B La histerectomía

C La mortalidad por sangrado precoz

D El sangrado

Q069 · PBM-08 AVANZADO

69. En CRASH-3, el TXA mostró beneficio en el TCE:

A Grave establecido

B Leve-moderado (RR 0,78)

C De cualquier gravedad por igual

D Penetrante solo

Q070 · PBM-08 AVANZADO

70. En ATACAS (cirugía coronaria), el TXA se asoció a:

A Más muerte

B Menos transfusión y reoperación, pero más convulsiones

C Menos convulsiones

D Más infarto

Q071 · PBM-08 BASICO

71. El riesgo trombótico del TXA en los grandes ensayos fue:

A Muy elevado
B Igual al de la heparina
C Desconocido
D Bajo

Q072 · PBM-08 AVANZADO

72. ¿Dónde NO hay que esperar gran beneficio del TXA?

A Hemorragia posparto
B Trauma con hemorragia
C Cirugía mayor
D TCE grave establecido

Q073 · PBM-08 BASICO

73. En CRASH-2, la muerte por hemorragia se redujo con un RR de:

A 0,99
B 1,20
C 0,85
D 0,40

Q074 · PBM-08 AVANZADO

74. El efecto adverso característico del TXA a dosis altas en cirugía cardíaca es:

A Hiperpotasemia
B Convulsiones
C Hipertermia maligna
D Anemia

PBM-09

Q075 · PBM-09 BASICO

75. ¿Qué miden las pruebas viscoelásticas que no ven el TP/TTPa?

A La firmeza del coágulo y la fibrinólisis en tiempo real
B La glucemia
C El grupo sanguíneo
D La saturación de oxígeno

Q076 · PBM-09 AVANZADO

76. Una firmeza baja del coágulo con vía del fibrinógeno deficitaria sugiere:

A Trombocitopenia
B Hiperfibrinólisis
C Déficit de factores
D Hipofibrinogenemia

Q077 · PBM-09 AVANZADO

77. Una lisis acelerada en viscoelástica indica:

A Trombocitopenia

B Déficit de factores

C Sobredosis de heparina

D Hiperfibrinólisis (dar tranexámico)

Q078 · PBM-09 AVANZADO

78. El metaanálisis Cochrane de TEG/ROTEM mostró reducción de transfusión de hematíes con RR:

A 0,20

B 0,86 (certeza baja)

C 1,50

D Sin efecto

Q079 · PBM-09 AVANZADO

79. La principal limitación de la evidencia viscoelástica es:

A Baja certeza y predominio de cirugía cardíaca

B No existe ningún ensayo

C Solo se ha estudiado en pediatría

D Aumenta la mortalidad

Q080 · PBM-09 BASICO

80. El orden lógico de un algoritmo guiado por viscoelástica suele ser:

A Tratar hiperfibrinólisis (TXA), luego fibrinógeno, luego plaquetas/factores

B Plaquetas primero siempre

C Plasma siempre primero

D Solo hematíes

Q081 · PBM-09 BASICO

81. Las pruebas convencionales (TP/TTPa) se diseñaron para:

A Guiar transfusión en hemorragia activa

B Diagnosticar coagulopatías

C Medir fibrinólisis

D Medir plaquetas

Q082 · PBM-09 BASICO

82. La viscoelástica debe considerarse:

A Una herramienta que complementa la hemostasia básica y el juicio

B Un oráculo que sustituye el juicio

C Innecesaria siempre

D Solo para investigación

PBM-10

Q083 · PBM-10 BASICO

83. El recuperador celular reinfunde:

A Hematíes propios lavados
B Plasma rico en factores
C Plaquetas
D Crioprecipitado

Q084 · PBM-10 AVANZADO

84. En la revisión Cochrane, el beneficio del recuperador fue más claro en cirugía de:

A Catarata
B Raquis (RR 0,44)
C Mano
D Tiroides

Q085 · PBM-10 BASICO

85. El recuperador celular rinde más cuando:

A El sangrado esperado es alto
B La cirugía es de bajo sangrado
C No hay anemia
D Se usa en todas las cirugías

Q086 · PBM-10 AVANZADO

86. La hemodilución normovolémica aguda consiste en:

A Transfundir antes de operar
B Extraer sangre al inicio y reinfundirla tras la fase de mayor sangrado
C Diluir el plasma
D Administrar EPO

Q087 · PBM-10 AVANZADO

87. Las precauciones clásicas del recuperador en campo contaminado u oncológico:

A Son absolutas siempre
B Impiden todo uso
C Se han matizado con técnicas como leucorreducción/irradiación
D No existen

Q088 · PBM-10 BASICO

88. El recuperador celular debe indicarse:

A Por rutina en toda cirugía
B Según la pérdida esperada
C Solo en cirugía menor
D Nunca en cardiovascular

Q089 · PBM-10 AVANZADO

89. En cirugía de raquis, el recuperador redujo la necesidad de transfusión con RR:

A 0,44

B 0,98

C 1,30

D 0,05

PBM-11

Q090 · PBM-11 BASICO

90. ¿Qué estima la MABL?

A Cuánto puede perder el paciente hasta el Hto/Hb diana

B El volumen tumoral

C La dosis de heparina

D El gasto cardíaco

Q091 · PBM-11 BASICO

91. Las ecuaciones de Nadler estiman:

A El hematocrito

B La pérdida intraoperatoria

C El volumen sanguíneo a partir de talla y peso

D La dosis de hierro

Q092 · PBM-11 AVANZADO

92. La fórmula de Gross para la MABL usa en el denominador:

A El Hto medio (media de inicial y diana)

B El Hto inicial

C El Hto diana

D El peso

Q093 · PBM-11 AVANZADO

93. Varón 80 kg, 1,75 m, Hto 42→28%. La MABL aproximada es:

A ≈ 500 ml

B ≈ 1000 ml

C ≈ 4000 ml

D ≈ 2060 ml

Q094 · PBM-11 BASICO

94. Regla rápida del volumen sanguíneo en el varón adulto:

A ≈ 30 ml/kg

B ≈ 70 ml/kg

C ≈ 50 ml/kg

D ≈ 100 ml/kg

Q095 · PBM-11 AVANZADO

95. Un error frecuente con la MABL es:

A Tratarla como permiso de sangrado o disparador automático de transfusión

B Calcularla con Nadler

C Usar el Hto medio

D Reevaluar la clínica

Q096 · PBM-11 AVANZADO

96. La MABL asume condiciones que la clínica no siempre cumple, como:

A Hipovolemia mantenida

B Coagulopatía severa

C Normovolemia y reposición ideal

D Hemólisis

Q097 · PBM-11 BASICO

97. Si la pérdida esperada se acerca a la MABL, conviene:

A No hacer nada

B Transfundir profilácticamente

C Optimizar la Hb previa, minimizar pérdida y planificar disponibilidad

D Cancelar siempre la cirugía

Q098 · PBM-11 BASICO

98. La referencia clásica del volumen sanguíneo es:

A Gross 1983

B Carson 2023

C Nadler 1962

D Holcomb 2015

PBM-12

Q099 · PBM-12 BASICO

99. La estrategia restrictiva de hematíes transfunde con un umbral de Hb típicamente de:

A 9-10 g/dl

B 11-12 g/dl

C < 5 g/dl

D 7-8 g/dl

Q100 · PBM-12 BASICO

100. El ensayo fundacional de la estrategia restrictiva en críticos es:

A TRISS

B REALITY

C PROPPR

D TRICC

Q101 · PBM-12 AVANZADO

101. En TRISS (shock séptico), la mortalidad a 90 días entre umbral 7 y 9 g/dl fue:

A Mucho mayor con restrictivo

B Equivalente (RR 0,94) con menos transfusiones

C Mucho menor con liberal

D No evaluable

Q102 · PBM-12 AVANZADO

102. En el síndrome coronario agudo, la evidencia reciente favorece un umbral:

A Más restrictivo (< 6)

B Sin transfundir nunca

C Idéntico al resto

D Más liberal (≈ 10 g/dl)

Q103 · PBM-12 AVANZADO

103. En el metaanálisis de datos individuales en infarto, la muerte cardíaca a 30 días con estrategia restrictiva fue:

A Menor (RR 0,50)

B Mayor (5,5% vs 3,7%; RR 1,47)

C Idéntica

D No medida

Q104 · PBM-12 BASICO

104. La revisión Cochrane 2025 halló que la estrategia restrictiva reduce la transfusión en torno a:

A 10%

B 42% (RR 0,58)

C 80%

D No la reduce

Q105 · PBM-12 AVANZADO

105. En TRICC, los pacientes con estrategia restrictiva tuvieron mortalidad hospitalaria:

A Mayor

B Significativamente menor (22,2% vs 28,1%)

C Idéntica

D No registrada

Q106 · PBM-12 AVANZADO

106. En REALITY (infarto + anemia), la estrategia restrictiva (≤8) frente a liberal (≤10) fue:

A Superior claramente

B No inferior, pero con IC que incluía posible daño

C Muy inferior

D No concluyente por falta de datos

Q107 · PBM-12 AVANZADO

107. En la revisión Cochrane, en hemorragia digestiva la estrategia restrictiva mostró:

A Mayor mortalidad

B Menor mortalidad

C Sin datos

D Más infecciones

Q108 · PBM-12 AVANZADO

108. En lesión cerebral aguda, la revisión Cochrane sugiere mejores desenlaces neurológicos con:

A Estrategia liberal

B Estrategia restrictiva

C No transfundir

D Sin diferencia

Q109 · PBM-12 BASICO

109. El umbral de transfusión debe entenderse como:

A Un disparador obligatorio

B Una referencia que integra la clínica

C Una norma legal

D Independiente del contexto

Q110 · PBM-12 BASICO

110. La guía CHEST 2024 recomienda, en el paciente crítico, una estrategia restrictiva salvo en:

A Sepsis

B Síndrome coronario agudo

C Postoperatorio

D Anemia leve

PBM-13

Q111 · PBM-13 BASICO

111. En la hemorragia crítica, respecto a los umbrales restrictivos:

A Se aplican igual

B Se elevan a 15 g/dl

C No se aplican: prioridad es controlar sangrado y coagulación

D Se ignora la coagulación

Q112 · PBM-13 BASICO

112. En PROPPR, la proporción de hemoderivados comparada fue:

A 2:1:1 vs 1:2:1

B Solo hematíes

C 1:1:1 vs 1:1:2

D 1:1:1 vs 3:3:3

Q113 · PBM-13 AVANZADO

113. PROPPR mostró que el grupo 1:1:1, frente a 1:1:2:

A Redujo significativamente la mortalidad a 30 días

B Logró más hemostasia y menos muerte por exanguinación a 24 h

C Aumentó las complicaciones

D No tuvo diferencias en nada

Q114 · PBM-13 BASICO

114. La 'resucitación de control de daños' incluye:

A Cristaloides abundantes

B Solo coloides

C Limitar cristaloides y transfundir equilibrado y precoz

D Esperar al control quirúrgico para transfundir

Q115 · PBM-13 AVANZADO

115. La hipocalcemia en la transfusión masiva se debe a:

A Pérdida renal

B El citrato de los hemoderivados que quela el calcio

C Hemólisis

D Hiperventilación

Q116 · PBM-13 BASICO

116. En el protocolo de transfusión masiva, el tranexámico debe administrarse:

A Precozmente, desde el inicio

B Al final

C Solo si hay coagulopatía confirmada

D Nunca

Q117 · PBM-13 BASICO

117. Las 'tres C' del entorno en transfusión masiva son:

A Cristaloides, coloides, concentrados

B Calcio, calor (temperatura) y corrección del pH

C Cirugía, control, comunicación

D Citrato, calcio, cloro

Q118 · PBM-13 AVANZADO

118. Tras la fase inicial equilibrada, lo ideal es transitar a:

A Manejo guiado por objetivos (viscoelástica, fibrinógeno)

B Solo cristaloides

C Suspender la transfusión

D Umbrales restrictivos clásicos

Q119 · PBM-13 BASICO

119. En la hemorragia masiva, las plaquetas se manejan:

A Dentro del protocolo de transfusión masiva

B Por los umbrales profilácticos habituales

C Nunca

D Solo si < 10 ×10⁹/l

Q120 · PBM-13 AVANZADO

120. PROPPR fue, respecto a su desenlace primario (mortalidad):

A Positivo

B Detenido por daño

C No aleatorizado

D Neutro (sin diferencia significativa)

PBM-14

Q121 · PBM-14 BASICO

121. La entrega de oxígeno (DO2) depende sobre todo de:

A La temperatura

B La diuresis

C El gasto cardíaco y el contenido arterial de O2 (Hb y SaO2)

D El pH urinario

Q122 · PBM-14 AVANZADO

122. ¿Por qué se tolera la anemia moderada?

A Porque no afecta a los tejidos

B Por aumento de la viscosidad

C Por descenso del gasto cardíaco

D Por mecanismos compensatorios (más gasto y extracción de O2)

Q123 · PBM-14 BASICO

123. Condición indispensable para que funcionen los mecanismos compensatorios de la anemia:

A Hipovolemia

B Hipotermia

C Acidosis

D Normovolemia

Q124 · PBM-14 AVANZADO

124. El órgano más vulnerable a la anemia por extraer O2 casi al máximo en basal es:

A El hígado

B El riñón

C El bazo

D El corazón

Q125 · PBM-14 AVANZADO

125. Una palanca para mejorar la tolerancia a la anemia es:

A Aumentar el consumo de O2

B Provocar fiebre

C Reducir el consumo de O2 (analgesia, normotermia)

D Inducir taquicardia

Q126 · PBM-14 AVANZADO

126. La 'anemia crítica' es el punto en que:

A La Hb sube

B La DO2 ya no cubre el consumo y aparece metabolismo anaerobio

C Se normaliza el lactato

D Mejora la extracción

Q127 · PBM-14 BASICO

127. El umbral único de Hb es, según la revisión Cochrane:

A Una aproximación útil, no universal

B Una verdad fisiológica universal

C Irrelevante

D Idéntico para todos los órganos

Q128 · PBM-14 BASICO

128. Un signo de mala tolerancia a la anemia que indica transfundir es:

A Diuresis normal

B Isquemia miocárdica o lactato elevado

C TA estable

D Buena saturación venosa

PBM-15

Q129 · PBM-15 BASICO

129. El cribado correcto del riesgo hemorrágico preoperatorio es:

A La anamnesis estructurada (p. ej. HEMSTOP)

B TP/TTPa de rutina a todos

C La ecografía

D El recuento plaquetario aislado

Q130 · PBM-15 BASICO

130. HEMSTOP es un cuestionario de:

A 7 ítems

B 3 ítems

C 12 ítems

D 20 ítems

Q131 · PBM-15 AVANZADO

131. Una puntuación HEMSTOP que indica estudio dirigido es:

A ≥ 1

B ≥ 4

C ≥ 6

D ≥ 2

Q132 · PBM-15 AVANZADO

132. La sensibilidad de las pruebas de coagulación estándar para detectar trastornos hemorrágicos fue, frente a HEMSTOP:

A Superior

B Idéntica

C Del 100%

D Mucho menor (≈ 26%)

Q133 · PBM-15 BASICO

133. Muchos trastornos hemorrágicos relevantes (von Willebrand) cursan con:

A TP/TTPa normales

B TP/TTPa muy alterados

C Plaquetas en cero

D Fibrinógeno alto

Q134 · PBM-15 BASICO

134. La 'M' de HEMSTOP corresponde a:

A Migraña

B Menorragia

C Melena

D Mareo

Q135 · PBM-15 AVANZADO

135. Ante un cribado positivo, además del estudio dirigido conviene:

A Operar de inmediato

B Transfundir plaquetas

C Revisar la medicación antitrombótica y valorar hematología

D Dar plasma profiláctico

Q136 · PBM-15 BASICO

136. Un HEMSTOP de 0 sin fármacos antitrombóticos:

A Obliga a estudio amplio

B Indica transfusión

C Requiere viscoelástica

D Hace muy improbable un trastorno hemorrágico oculto

PBM-16

Q137 · PBM-16 BÁSICO

137. El manejo perioperatorio de antitrombóticos equilibra:

A Riesgo de trombosis frente a riesgo de sangrado

B Coste y disponibilidad

C Dolor y náuseas

D Diuresis e hidratación

Q138 · PBM-16 AVANZADO

138. La decisión sobre antitrombóticos cruza tres ejes:

A Fármaco × riesgo trombótico × riesgo hemorrágico del procedimiento

B Edad, sexo y peso

C Hb, plaquetas y fibrinógeno

D Tensión, FC y diuresis

Q139 · PBM-16 AVANZADO

139. El ensayo BRIDGE mostró que, en fibrilación auricular, NO hacer puente con heparina:

A Aumentó la trombosis

B Aumentó la mortalidad

C No tuvo efecto en el sangrado

D Fue no inferior para tromboembolismo y redujo la hemorragia mayor (RR 0,41)

Q140 · PBM-16 BÁSICO

140. La aspirina en prevención secundaria, en cirugía de riesgo hemorrágico bajo-moderado:

A A menudo puede mantenerse

B Siempre se suspende

C Se sustituye por warfarina

D Se duplica la dosis

Q141 · PBM-16 AVANZADO

141. La reversión urgente de los antagonistas de la vitamina K se hace con:

A Plasma siempre

B Plaquetas

C Desmopresina

D Concentrado de complejo protrombínico (CCP) + vitamina K

Q142 · PBM-16 AVANZADO

142. Los anticoagulantes orales de acción directa (ACOD) habitualmente:

A Se suspenden según fármaco y función renal, sin puente

B Requieren puente con heparina

C No se suspenden nunca

D Se revierten solo con plasma

Q143 · PBM-16 BASICO

143. En el paciente con stent coronario reciente y doble antiagregación, lo prudente es:

A Operar de inmediato sin más

B Suspender todo siempre

C Posponer la cirugía electiva y decidir en equipo si es inaplazable

D Duplicar antiagregantes

Q144 · PBM-16 BASICO

144. El 'puente' sistemático con heparina en FA, según BRIDGE:

A Es beneficioso en todos

B Añade sangrado sin proteger de la trombosis en la mayoría

C Reduce la mortalidad

D Es obligatorio

Q145 · PBM-16 AVANZADO

145. Los inhibidores de P2Y12 (clopidogrel, ticagrelor) en cirugía mayor:

A Suelen suspenderse unos días antes

B Se mantienen siempre

C Se cambian por aspirina sin más

D No afectan al sangrado

Q146 · PBM-16 BASICO

146. La reanudación de antitrombóticos debe:

A Ser inmediata siempre

B Equilibrar la hemostasia quirúrgica con el riesgo trombótico, coordinada entre equipos

C Retrasarse semanas siempre

D Decidirla el paciente

PBM-17

Q147 · PBM-17 BASICO

147. La coagulopatía congénita más frecuente es:

A Hemofilia A

B Déficit de factor XIII

C Enfermedad de von Willebrand

D Afibrinogenemia

Q148 · PBM-17 BASICO

148. Las coagulopatías congénitas exigen, en general:

A Tratamiento improvisado intraoperatorio

B Solo plasma

C Plan anticipado con hematología y tratamiento específico

D Ningún plan especial

Q149 · PBM-17 AVANZADO

149. En la coagulopatía hepática, transfundir plasma por un INR alterado SIN sangrado:

A No está indicado

B Es lo recomendado

C Reduce la mortalidad

D Corrige siempre el INR

Q150 · PBM-17 BASICO

150. Las hemofilias A y B son déficit de:

A Fibrinógeno

B Factores VIII y IX

C Factor V y X

D Plaquetas

Q151 · PBM-17 AVANZADO

151. Las coagulopatías adquiridas se tratan, en general:

A Con 'recetas' fijas

B Solo con plaquetas

C Ignorando la causa

D Corrigiendo la causa y el déficit dirigido (mejor guiado por viscoelástica)

Q152 · PBM-17 BASICO

152. La regla de oro ante una posible coagulopatía es:

A Esperar a la hemorragia

B Transfundir profilácticamente

C Anticipar (el peor momento para descubrirla es durante el sangrado)

D Evitar la cirugía siempre

Q153 · PBM-17 AVANZADO

153. En la von Willebrand tipo 1 respondedora, una opción terapéutica es:

A Desmopresina o concentrado de FvW/FVIII

B Warfarina

C Aspirina

D Heparina

Q154 · PBM-17 AVANZADO

154. La von Willebrand suele cursar con TP/TTPa:

A Muy alterados

B Imposibles de medir

C Normales

D Solo TP alterado

PBM-18

Q155 · PBM-18 BASICO

155. El concentrado de complejo protrombínico (CCP) aporta:

A Factores dependientes de vitamina K (II, VII, IX, X)

B Plaquetas

C Fibrinógeno puro

D Hematíes

Q156 · PBM-18 BASICO

156. El concentrado de fibrinógeno se indica cuando, en sangrado, el fibrinógeno es:

A < 4 g/l

B > 3 g/l

C Siempre

D < 1,5 g/l o déficit funcional

Q157 · PBM-18 AVANZADO

157. El factor VII activado recombinante (rFVIIa) en hemorragia perioperatoria refractaria es:

A Tratamiento de primera línea

B Sin riesgos

C Un recurso de rescate off-label con riesgo trombótico

D Equivalente al fibrinógeno

Q158 · PBM-18 BASICO

158. La desmopresina (DDAVP) es útil en:

A Hemofilia B grave

B Von Willebrand tipo 1 respondedora y disfunción plaquetaria

C Déficit de fibrinógeno

D CID

Q159 · PBM-18 AVANZADO

159. Un efecto a vigilar con la desmopresina es:

A Hipernatremia

B Hiponatremia (efecto antidiurético)

C Hiperglucemia

D Hipertermia

Q160 · PBM-18 AVANZADO

160. El rFVIIa NO sustituye:

A A la anestesia

B A la analgesia

C Al control quirúrgico ni a la corrección del entorno

D A la profilaxis antibiótica

Q161 · PBM-18 BASICO

161. El principio común de los fármacos hemostáticos es usarlos:

A A ciegas
B Siempre combinados
C Dirigidos al déficit demostrado (idealmente guiados por viscoelástica)
D Solo en UCI

Q162 · PBM-18 AVANZADO

162. Frente al plasma, el CCP para revertir AVK es:

A Más lento
B Más rápido y eficaz
C Menos seguro siempre
D Equivalente en velocidad

Q163 · PBM-18 BASICO

163. En Europa, el concentrado de fibrinógeno frente al crioprecipitado:

A Lo ha desplazado en gran medida por estandarización y seguridad
B Está prohibido
C Es idéntico
D Aporta plaquetas

P-QR-01

Q164 · P-QR-01 BASICO

164. El pilar 1 del PBM se centra en:

A Minimizar la pérdida
B Optimizar la masa eritrocitaria
C Tolerar la anemia
D La hemostasia

Q165 · P-QR-01 BASICO

165. El pilar 2 del PBM se centra en:

A Optimizar la masa eritrocitaria
B Minimizar la pérdida sanguínea
C Tolerar la anemia
D Cribar coagulopatías

Q166 · P-QR-01 BASICO

166. El pilar 3 del PBM se centra en:

A Optimizar la masa eritrocitaria
B Minimizar la pérdida
C Optimizar y tolerar la anemia
D Fármacos hemostáticos

Q167 · P-QR-01 BASICO

167. La 'regla de oro' del PBM es:

A Transfundir pronto

B Usar siempre coloides

C Evitar el hierro

D La mejor unidad es la que no hace falta transfundir

Q168 · P-QR-01 AVANZADO

168. En el postoperatorio, dentro del pilar 3, se recomienda:

A Umbral liberal

B Umbral restrictivo y transfusión unitaria

C No medir la Hb

D Transfundir 2 unidades por defecto

Q169 · P-QR-01 BASICO

169. El eje transversal de la serie abarca los documentos:

A PBM-01 a 03

B PBM-04 a 06

C PBM-07 a 11

D PBM-15 a 18

P-QR-02

Q170 · P-QR-02 BASICO

170. Umbral de hematíes en el paciente estable:

A < 7 g/dl

B < 9 g/dl

C < 10 g/dl

D < 11 g/dl

Q171 · P-QR-02 BASICO

171. Umbral de hematíes en ortopedia o enfermedad cardiovascular crónica:

A < 8 g/dl

B < 6 g/dl

C < 7 g/dl

D < 10 g/dl

Q172 · P-QR-02 AVANZADO

172. En el SCA, el umbral recomendado es:

A < 7 g/dl restrictivo

B < 6 g/dl

C Sin transfundir

D Liberal ≈ 10 g/dl

Q173 · P-QR-02 AVANZADO

173. Umbral de plaquetas para cirugía mayor no neuroaxial (2025):

A < 10 ×10⁹/l

B < 50 ×10⁹/l

C < 20 ×10⁹/l

D < 100 ×10⁹/l

Q174 · P-QR-02 AVANZADO

174. Cambio 2025 vs 2015 en plaquetas: punción lumbar y CVC pasan a:

A 50→20 y 20→10

B 20→50 y 10→20

C Sin cambios

D 10→5 y 5→2

Q175 · P-QR-02 BASICO

175. Dosis habitual de plasma fresco congelado:

A 1-2 ml/kg

B 30-40 ml/kg

C 10-15 ml/kg

D 60 ml/kg

Q176 · P-QR-02 BASICO

176. En hemorragia masiva, ¿qué rige en vez de los umbrales por componente?

A El protocolo de transfusión masiva

B La diuresis

C La presión venosa central

D El peso

Q177 · P-QR-02 AVANZADO

177. Dosis de plaquetas por episodio profiláctico:

A Media unidad de aféresis no es eficaz

B Hasta una unidad de aféresis (dosis mayores no son más eficaces)

C Tres unidades de aféresis

D Diez pools

P-QR-03

Q178 · P-QR-03 BASICO

178. Mensaje transversal del TXA en todos los escenarios:

A Cuanto más tarde mejor

B Solo por vía oral

C Cuanto antes, mejor (idealmente < 3 h)

D Dosis única siempre

Q179 · P-QR-03 BASICO

179. Pauta de TXA en hemorragia posparto (WOMAN):

A 5 g en bolo

B 500 mg oral

C 1 g IV, repetible a los 30 min

D Infusión de 24 h

Q180 · P-QR-03 AVANZADO

180. En cirugía cardíaca, vigilar con dosis altas de TXA:

A Hipertermia maligna

B Hipoglucemia

C Convulsiones

D Sordera

Q181 · P-QR-03 AVANZADO

181. En el TCE grave establecido, el TXA:

A Es muy eficaz

B Tiene efecto limitado

C Está contraindicado por trombosis

D Reduce la mortalidad un 50%

Q182 · P-QR-03 BASICO

182. Pauta de carga de TXA en trauma:

A 100 mg en bolo

B 2 g en 1 min

C Infusión sin carga

D 1 g en 10 min

Q183 · P-QR-03 BASICO

183. El TXA reduce de forma demostrada en trauma y posparto:

A La estancia en UCI

B La infección

C La muerte por hemorragia

D El dolor

Q184 · P-QR-03 AVANZADO

184. En cirugía, el principal beneficio del TXA es:

A Reducir transfusión y reoperación

B Curar la anemia

C Revertir anticoagulantes

D Aumentar el gasto cardíaco

P-QR-04

Q185 · P-QR-04 BASICO

185. La MABL es:

A Un disparador de transfusión
B Una herramienta de planificación
C Una dosis de fármaco
D Un umbral de Hb

Q186 · P-QR-04 AVANZADO

186. En la fórmula de Nadler, las variables de entrada son:

A Edad y sexo
B Talla y peso
C Hb y Hto
D FC y TA

Q187 · P-QR-04 AVANZADO

187. El Hto medio en la fórmula de Gross es:

A El Hto inicial
B El Hto diana
C Siempre 40%
D La media de Hto inicial y diana

Q188 · P-QR-04 BASICO

188. La MABL se decide junto con:

A El umbral de Hb y la clínica (sangrado activo)
B Solo el peso
C El grupo sanguíneo
D La diuresis

Q189 · P-QR-04 AVANZADO

189. Si la pérdida esperada se acerca a la MABL, una medida es:

A No optimizar nada
B Activar ahorro de sangre (recuperador, TXA) y planificar disponibilidad
C Transfundir profilácticamente
D Aumentar cristaloides

Q190 · P-QR-04 BASICO

190. Regla rápida del volumen sanguíneo en la mujer:

A ≈ 50 ml/kg
B ≈ 80 ml/kg
C ≈ 100 ml/kg
D ≈ 65 ml/kg

Q191 · P-QR-04 AVANZADO

191. La MABL conecta los tres pilares porque permite:

A Solo medir la Hb

B Anticipar: optimizar Hb, minimizar pérdida y planificar transfusión

C Evitar la cirugía

D Sustituir la viscoelástica

P-QR-05

Q192 · P-QR-05 BASICO

192. Las tres preguntas antes de decidir sobre antitrombóticos son:

A Fármaco/vida media, riesgo trombótico del paciente, riesgo hemorrágico del procedimiento

B Edad, sexo, peso

C Hb, plaquetas, fibrinógeno

D TA, FC, diuresis

Q193 · P-QR-05 AVANZADO

193. Los tiempos exactos de suspensión de cada antitrombótico se toman de:

A La memoria

B Un solo ensayo

C La preferencia del paciente

D El protocolo local y la ficha técnica vigentes

Q194 · P-QR-05 BASICO

194. En FA, el puente con heparina debe reservarse para:

A Todos los pacientes

B Bajo riesgo

C Alto riesgo trombótico seleccionado

D Nunca usarse

Q195 · P-QR-05 AVANZADO

195. La reversión urgente de AVK en la tarjeta remite a:

A Plaquetas

B Desmopresina

C Fibrinógeno

D CCP + vitamina K (PBM-18)

Q196 · P-QR-05 BASICO

196. En BRIDGE, la hemorragia mayor con puente frente a no puente fue:

A Menor con puente

B Idéntica

C No medida

D Mayor con puente (3,2% vs 1,3%)

Q197 · P-QR-05 AVANZADO

197. La reanudación de antitrombóticos tras cirugía debe ser:

A Escalonada y coordinada cuando la hemostasia lo permita

B Inmediata y completa

C A las 6 semanas siempre

D Decidida por el paciente

PBM-12

Q198 · PBM-12 BASICO

198. La estrategia restrictiva funciona porque el paciente:

A No tolera la anemia

B Aumenta su Hb solo

C Tolera grados moderados de anemia por mecanismos compensatorios

D No necesita oxígeno

PBM-02

Q199 · PBM-02 BASICO

199. El crioprecipitado es la fracción rica en:

A Hematíes

B Plaquetas

C Albúmina

D Fibrinógeno (y FVIII, FXIII, FvW)

PBM-13

Q200 · PBM-13 BASICO

200. La activación del protocolo de transfusión masiva debe ser:

A Tardía y cautelosa

B Solo tras pruebas de laboratorio

C Precoz ante hemorragia no controlada

D Opcional

---

2. Soluciones razonadas

1. Q001 — Respuesta: *A*. El PBM desplaza el foco del producto al paciente: cómo evitar que necesite transfusión. *(PMID 30860564 · PBM-01)*

2. Q002 — Respuesta: *A*. Los 3 pilares: optimizar masa eritrocitaria, minimizar la pérdida sanguínea y optimizar/tolerar la anemia. *(PMID 30860564 · PBM-01)*

3. Q003 — Respuesta: *D*. RR 0,61 (−39%); es el efecto más consistente de los programas PBM. *(PMID 30418206 · PBM-01)*

4. Q004 — Respuesta: *D*. Gran parte es observacional; el ahorro de sangre es sólido, los desenlaces duros más débiles. *(PMID 30418206 · PBM-01)*

5. Q005 — Respuesta: *A*. El consenso de Frankfurt 2018 (Mueller et al., JAMA 2019) vertebra las recomendaciones de PBM. *(PMID 30860564 · PBM-01)*

6. Q006 — Respuesta: *D*. El eje transversal es la evaluación y manejo del sangrado y las coagulopatías. *(PMID 36855941 · PBM-01)*

7. Q007 — Respuesta: *B*. Mortalidad RR 0,89 (IC 0,80-0,98), asociación de certeza moderada. *(PMID 30418206 · PBM-01)*

8. Q008 — Respuesta: *B*. Es multimodal y multidisciplinar: anestesia, cirugía, hematología, enfermería y banco de sangre. *(PMID 30860564 · PBM-01)*

9. Q009 — Respuesta: *D*. La transfusión es el último recurso cuando las demás medidas no bastan. *(PMID 30860564 · PBM-01)*

10. Q010 — Respuesta: *D*. Los hematíes mejoran el transporte de oxígeno. *(PMID 37824153 · PBM-02)*

11. Q011 — Respuesta: *A*. Recomendación fuerte: considerar transfusión con Hb < 7 g/dl en el paciente estable. *(PMID 37824153 · PBM-02)*

12. Q012 — Respuesta: *B*. 7,5 g/dl en cirugía cardíaca, en línea con los ensayos. *(PMID 37824153 · PBM-02)*

13. Q013 — Respuesta: *C*. ≈ +1 g/dl (Hto ≈ +3%); transfundir de unidad en unidad y reevaluar. *(PMID 37824153 · PBM-02)*

14. Q014 — Respuesta: *C*. Profilaxis con < 10 ×10⁹/l (recomendación fuerte). *(PMID 40440268 · PBM-02)*

15. Q015 — Respuesta: *A*. La actualización 2025 bajó el dintel de punción lumbar a < 20 ×10⁹/l (antes 50). *(PMID 40440268 · PBM-02)*

16. Q016 — Respuesta: *D*. Recomendación en contra de transfundir (en línea con el ensayo PATCH). *(PMID 40440268 · PBM-02)*

17. Q017 — Respuesta: *D*. Su indicación es el sangrado con coagulopatía documentada; dosis 10-15 ml/kg. *(PMID 29527654 · PBM-02)*

18. Q018 — Respuesta: *A*. Reponer fibrinógeno si < 1,5 g/l o déficit funcional en el contexto de sangrado. *(PMID 36855941 · PBM-02)*

19. Q019 — Respuesta: *D*. No se recomienda la transfusión profiláctica de plaquetas en ese contexto. *(PMID 40440268 · PBM-02)*

20. Q020 — Respuesta: *C*. Transfundir 'por el número' sin contexto clínico es la fuente más común de uso inapropiado. *(PMID 37824153 · PBM-02)*

21. Q021 — Respuesta: *A*. El error administrativo de identificación es el principal riesgo letal evitable. *(PMID 27083327 · PBM-03)*

22. Q022 — Respuesta: *C*. La verificación positiva de identidad paciente-unidad antes de conectar es la barrera clave. *(PMID 27083327 · PBM-03)*

23. Q023 — Respuesta: *A*. TACO = sobrecarga circulatoria; cursa con edema pulmonar hidrostático. *(PMID 27083327 · PBM-03)*

24. Q024 — Respuesta: *B*. TACO: hidrostático por volumen; TRALI: lesión pulmonar inmunomediada. *(PMID 27083327 · PBM-03)*

25. Q025 — Respuesta: *C*. Detener de inmediato, mantener vía, reevaluar identidad y avisar al banco. *(PMID 27083327 · PBM-03)*

26. Q026 — Respuesta: *D*. La irradiación de componentes previene la TA-GVHD en pacientes de riesgo. *(PMID 27083327 · PBM-03)*

27. Q027 — Respuesta: *A*. Debe poder seguirse del donante al receptor y viceversa; es exigencia legal en la UE. *(PMID 27083327 · PBM-03)*

28. Q028 — Respuesta: *C*. Pensar TACO primero: más frecuente y a menudo infradiagnosticado. *(PMID 27083327 · PBM-03)*

29. Q029 — Respuesta: *C*. Ritmo lento, una unidad cada vez y valorar el balance. *(PMID 27083327 · PBM-03)*

30. Q030 — Respuesta: *D*. La ferropenia (absoluta o funcional) es la causa principal. *(PMID 38664944 · PBM-04)*

31. Q031 — Respuesta: *A*. Anemia: Hb < 130 g/l (varón) y < 120 g/l (mujer). *(PMID 38664944 · PBM-04)*

32. Q032 — Respuesta: *D*. Cribar precozmente para disponer de margen terapéutico. *(PMID 38664944 · PBM-04)*

33. Q033 — Respuesta: *B*. La inflamación eleva la ferritina; debe interpretarse junto a la PCR. *(PMID 38664944 · PBM-04)*

34. Q034 — Respuesta: *C*. Con inflamación, ferritina hasta ≈ 100 µg/l con saturación de transferrina baja sugiere ferropenia. *(PMID 38664944 · PBM-04)*

35. Q035 — Respuesta: *C*. Transfundir para 'subir la Hb' el día de la operación es el peor abordaje. *(PMID 38664944 · PBM-04)*

36. Q036 — Respuesta: *C*. Ferritina < 30 µg/l = ferropenia absoluta casi segura. *(PMID 38664944 · PBM-04)*

37. Q037 — Respuesta: *D*. La saturación de transferrina baja orienta a ferropenia funcional. *(PMID 38664944 · PBM-04)*

38. Q038 — Respuesta: *D*. Predice mayor necesidad transfusional y peores desenlaces. *(PMID 38664944 · PBM-04)*

39. Q039 — Respuesta: *B*. Dosis más bajas y menos frecuentes mejoran la absorción fraccional (hepcidina). *(PMID 38664944 · PBM-05)*

40. Q040 — Respuesta: *C*. IV preferente ante intolerancia/ineficacia oral, malabsorción, anemia moderada-grave o poco margen. *(PMID 38664944 · PBM-05)*

41. Q041 — Respuesta: *B*. PREVENTT fue neutro en su desenlace primario (RR 1,03; IC 0,78-1,37). *(PMID 32896294 · PBM-05)*

42. Q042 — Respuesta: *D*. El mensaje es diagnosticar la ferropenia y tratarla con tiempo, no hierro IV universal de última hora. *(PMID 32896294 · PBM-05)*

43. Q043 — Respuesta: *C*. Funcional: saturación de transferrina baja con ferritina normal-alta. *(PMID 38664944 · PBM-05)*

44. Q044 — Respuesta: *C*. Dosis única de 1000 mg de carboximaltosa férrica. *(PMID 32896294 · PBM-05)*

45. Q045 — Respuesta: *C*. Hierro IV ± EPO (ver PBM-06). *(PMID 38664944 · PBM-05)*

46. Q046 — Respuesta: *C*. Necesita varias semanas; por eso importa el margen temporal. *(PMID 38664944 · PBM-05)*

47. Q047 — Respuesta: *C*. Sin hierro adecuado la respuesta es pobre; EPO se da con hierro. *(PMID 39764839 · PBM-06)*

48. Q048 — Respuesta: *A*. Alta dosis de ESA + hierro 3-4 semanas antes eleva la Hb perioperatoria. *(PMID 39764839 · PBM-06)*

49. Q049 — Respuesta: *D*. El riesgo tromboembólico obliga a indicación selectiva y a valorar el balance. *(PMID 39764839 · PBM-06)*

50. Q050 — Respuesta: *C*. Rechazo de transfusión, anemia renal/inflamatoria y ferropenia funcional son indicaciones sólidas. *(PMID 39764839 · PBM-06)*

51. Q051 — Respuesta: *B*. En cirugía oncológica el balance beneficio-riesgo debe valorarse con cuidado. *(PMID 39764839 · PBM-06)*

52. Q052 — Respuesta: *D*. Beneficio sobre todo en reducción de transfusión; señal en mortalidad escasa o nula. *(PMID 39764839 · PBM-06)*

53. Q053 — Respuesta: *D*. No sustituye al hierro; es una opción de segunda línea selectiva. *(PMID 39764839 · PBM-06)*

54. Q054 — Respuesta: *D*. La guía EACTS/EACTAIC 2024 respalda hierro y ESA en ese contexto. *(PMID 39385500 · PBM-06)*

55. Q055 — Respuesta: *B*. Modelo celular: iniciación, amplificación y propagación sobre superficies celulares. *(PMID 36855941 · PBM-07)*

56. Q056 — Respuesta: *D*. El fibrinógeno es el primer factor que desciende; su reposición es prioritaria. *(PMID 36855941 · PBM-07)*

57. Q057 — Respuesta: *C*. Hipotermia + acidosis deterioran factores y plaquetas, cerrando el círculo con la coagulopatía. *(PMID 36855941 · PBM-07)*

58. Q058 — Respuesta: *D*. El calcio iónico es imprescindible para la coagulación. *(PMID 36855941 · PBM-07)*

59. Q059 — Respuesta: *C*. Es un paquete multimodal; el efecto procede de la suma de medidas. *(PMID 36855941 · PBM-07)*

60. Q060 — Respuesta: *A*. Un paciente frío, acidótico e hipocalcémico no coagula por mucho factor que reciba. *(PMID 36855941 · PBM-07)*

61. Q061 — Respuesta: *D*. El exceso de fibrinólisis favorece el sangrado; de ahí el valor del tranexámico. *(PMID 36855941 · PBM-07)*

62. Q062 — Respuesta: *A*. El quirúrgico exige control mecánico; el coagulopático, corrección hemostática (orienta la viscoelástica). *(PMID 36855941 · PBM-07)*

63. Q063 — Respuesta: *C*. Análogo de lisina que estabiliza el coágulo inhibiendo la fibrinólisis. *(PMID 20554319 · PBM-08)*

64. Q064 — Respuesta: *A*. Mortalidad RR 0,91 (IC 0,85-0,97); muerte por sangrado RR 0,85. *(PMID 20554319 · PBM-08)*

65. Q065 — Respuesta: *A*. Cuanto antes se administra (idealmente < 3 h), mayor el beneficio. *(PMID 28456509 · PBM-08)*

66. Q066 — Respuesta: *B*. Carga de 1 g en 10 min seguida de 1 g en 8 h. *(PMID 20554319 · PBM-08)*

67. Q067 — Respuesta: *C*. Mayor efecto si < 3 h del parto (RR 0,69). *(PMID 28456509 · PBM-08)*

68. Q068 — Respuesta: *B*. No redujo la histerectomía (la decisión solía tomarse al incluir). *(PMID 28456509 · PBM-08)*

69. Q069 — Respuesta: *B*. Reducción de muerte por TCE en leve-moderado; sin señal clara en grave. *(PMID 31623894 · PBM-08)*

70. Q070 — Respuesta: *B*. Reduce hemorragia/transfusión sin más eventos trombóticos; ligero aumento de convulsiones a dosis altas. *(PMID 27774838 · PBM-08)*

71. Q071 — Respuesta: *D*. El riesgo de eventos oclusivos fue bajo en CRASH-2/WOMAN. *(PMID 20554319 · PBM-08)*

72. Q072 — Respuesta: *D*. En la lesión cerebral grave establecida el efecto es limitado. *(PMID 31623894 · PBM-08)*

73. Q073 — Respuesta: *C*. Muerte por sangrado RR 0,85 (IC 0,76-0,96). *(PMID 20554319 · PBM-08)*

74. Q074 — Respuesta: *B*. ATACAS mostró más convulsiones (0,7% vs 0,1%). *(PMID 27774838 · PBM-08)*

75. Q075 — Respuesta: *A*. Aportan una imagen funcional: formación, firmeza y lisis del coágulo en sangre total. *(PMID 27552162 · PBM-09)*

76. Q076 — Respuesta: *D*. Indica hipofibrinogenemia; acción: fibrinógeno o crioprecipitado. *(PMID 27552162 · PBM-09)*

77. Q077 — Respuesta: *D*. Lisis acelerada = hiperfibrinólisis; tratar con tranexámico. *(PMID 27552162 · PBM-09)*

78. Q078 — Respuesta: *B*. RR 0,86 para hematíes; también plasma (0,57) y plaquetas (0,73), con baja certeza. *(PMID 27552162 · PBM-09)*

79. Q079 — Respuesta: *A*. Beneficio probable pero de baja certeza, heterogéneo y derivado sobre todo de cirugía cardíaca. *(PMID 27552162 · PBM-09)*

80. Q080 — Respuesta: *A*. Primero TXA si hay lisis, luego fibrinógeno, después plaquetas y factores. *(PMID 36855941 · PBM-09)*

81. Q081 — Respuesta: *B*. No son ideales para guiar la transfusión en sangrado activo; tardan y no informan de firmeza ni lisis. *(PMID 27552162 · PBM-09)*

82. Q082 — Respuesta: *A*. Complementa, no sustituye, la hemostasia básica y el juicio clínico. *(PMID 27552162 · PBM-09)*

83. Q083 — Respuesta: *A*. Reinfunde hematíes propios lavados; no aporta factores ni plaquetas. *(PMID 37681564 · PBM-10)*

84. Q084 — Respuesta: *B*. Beneficio más claro en raquis (RR 0,44; certeza moderada). *(PMID 37681564 · PBM-10)*

85. Q085 — Respuesta: *A*. Su rendimiento es mayor cuanto mayor es la pérdida esperada. *(PMID 37681564 · PBM-10)*

86. Q086 — Respuesta: *B*. La sangre perdida queda más diluida y se devuelve sangre rica en células/factores después. *(PMID 36855941 · PBM-10)*

87. Q087 — Respuesta: *C*. Con filtración/irradiación su uso se ha extendido a escenarios antes vetados, según protocolo. *(PMID 37681564 · PBM-10)*

88. Q088 — Respuesta: *B*. Indicar según la pérdida esperada, no por rutina. *(PMID 37681564 · PBM-10)*

89. Q089 — Respuesta: *A*. RR 0,44 (certeza moderada) en raquis. *(PMID 37681564 · PBM-10)*

90. Q090 — Respuesta: *A*. Es una herramienta de planificación de la pérdida admisible. *(PMID 6829965 · PBM-11)*

91. Q091 — Respuesta: *C*. Nadler calcula el volumen sanguíneo estimado (VSE). *(PMID 21936146 · PBM-11)*

92. Q092 — Respuesta: *A*. MABL = VSE × (Hto_ini − Hto_diana) / Hto_medio. *(PMID 6829965 · PBM-11)*

93. Q093 — Respuesta: *D*. VSE ≈ 5,15 L; MABL = 5150 × 14/35 ≈ 2060 ml. *(PMID 6829965 · PBM-11)*

94. Q094 — Respuesta: *B*. ≈ 70 ml/kg (varón) y 65 ml/kg (mujer). *(PMID 21936146 · PBM-11)*

95. Q095 — Respuesta: *A*. Es una estimación de planificación, no un disparador de transfusión. *(PMID 6829965 · PBM-11)*

96. Q096 — Respuesta: *C*. Asume normovolemia y reposición ideal; no contempla coagulopatía por dilución. *(PMID 6829965 · PBM-11)*

97. Q097 — Respuesta: *C*. Conecta los tres pilares en una decisión anticipada. *(PMID 6829965 · PBM-11)*

98. Q098 — Respuesta: *C*. Nadler SB et al., Surgery 1962. *(PMID 21936146 · PBM-11)*

99. Q099 — Respuesta: *D*. Restrictivo ≈ 7-8 g/dl frente a liberal 9-10 g/dl. *(PMID 41114449 · PBM-12)*

100. Q100 — Respuesta: *D*. TRICC (Hébert, NEJM 1999) comparó Hb<7 vs <10 en críticos. *(PMID 9971864 · PBM-12)*

101. Q101 — Respuesta: *B*. 43,0% vs 45,0% (RR 0,94); la mitad de transfusiones en el grupo restrictivo. *(PMID 25270275 · PBM-12)*

102. Q102 — Respuesta: *D*. En SCA conviene un umbral liberal ≈ 10 g/dl (CHEST 2024 + metaanálisis). *(PMID 39341492 · PBM-12)*

103. Q103 — Respuesta: *B*. Mayor muerte cardíaca con restrictivo (RR 1,47; IC 1,11-1,94). *(PMID 39714935 · PBM-12)*

104. Q104 — Respuesta: *B*. RR 0,58 (−42%) sin aumentar la mortalidad a 30 días (RR 1,01). *(PMID 41114449 · PBM-12)*

105. Q105 — Respuesta: *B*. La mortalidad intrahospitalaria fue menor con restrictivo. *(PMID 9971864 · PBM-12)*

106. Q106 — Respuesta: *B*. MACE 11,0% vs 14,0%; no inferior pero el IC incluía un posible daño. *(PMID 33560322 · PBM-12)*

107. Q107 — Respuesta: *B*. En hemorragia digestiva el restrictivo redujo la mortalidad. *(PMID 41114449 · PBM-12)*

108. Q108 — Respuesta: *A*. En lesión cerebral, mejores desenlaces neurológicos con estrategia liberal. *(PMID 41114449 · PBM-12)*

109. Q109 — Respuesta: *B*. Es una referencia; integra síntomas, sangrado activo y comorbilidad. *(PMID 39341492 · PBM-12)*

110. Q110 — Respuesta: *B*. Restrictivo por defecto, salvo SCA (en contra de restrictivo). *(PMID 39341492 · PBM-12)*

111. Q111 — Respuesta: *C*. La lógica cambia: se activa un protocolo, no se espera a umbrales. *(PMID 36855941 · PBM-13)*

112. Q112 — Respuesta: *C*. Plasma:plaquetas:hematíes 1:1:1 frente a 1:1:2. *(PMID 25647203 · PBM-13)*

113. Q113 — Respuesta: *B*. Neutro en mortalidad, pero más hemostasia (86% vs 78%) y menos exanguinación (9,2% vs 14,6%). *(PMID 25647203 · PBM-13)*

114. Q114 — Respuesta: *C*. Hipotensión permisiva controlada, limitar cristaloides y transfusión precoz equilibrada. *(PMID 36855941 · PBM-13)*

115. Q115 — Respuesta: *B*. El citrato quela el calcio; hay que monitorizar y reponer calcio iónico. *(PMID 36855941 · PBM-13)*

116. Q116 — Respuesta: *A*. TXA precoz (CRASH-2: RR 0,85 para muerte por sangrado). *(PMID 20554319 · PBM-13)*

117. Q117 — Respuesta: *B*. Sin calcio, normotermia y pH adecuado, ningún ratio coagula bien. *(PMID 36855941 · PBM-13)*

118. Q118 — Respuesta: *A*. Empezar equilibrado y pasar a manejo guiado por objetivos. *(PMID 25647203 · PBM-13)*

119. Q119 — Respuesta: *A*. Se manejan dentro del protocolo, no por los umbrales profilácticos de PBM-02. *(PMID 40440268 · PBM-13)*

120. Q120 — Respuesta: *D*. No hubo diferencia significativa en mortalidad a 24 h ni 30 días. *(PMID 25647203 · PBM-13)*

121. Q121 — Respuesta: *C*. DO2 = gasto cardíaco × contenido arterial de O2. *(PMID 41114449 · PBM-14)*

122. Q122 — Respuesta: *D*. Aumento del gasto, redistribución, mayor extracción y 2,3-DPG. *(PMID 41114449 · PBM-14)*

123. Q123 — Respuesta: *D*. La hipovolemia anula la compensación del gasto cardíaco. *(PMID 41114449 · PBM-14)*

124. Q124 — Respuesta: *D*. El miocardio extrae O2 casi al máximo; por eso el SCA es la gran excepción. *(PMID 41114449 · PBM-14)*

125. Q125 — Respuesta: *C*. Analgesia, normotermia y tratar fiebre/agitación reducen el consumo de O2. *(PMID 41114449 · PBM-14)*

126. Q126 — Respuesta: *B*. Umbral en que la entrega no cubre el consumo; varía mucho entre pacientes. *(PMID 41114449 · PBM-14)*

127. Q127 — Respuesta: *A*. La tolerancia real depende del paciente; el umbral es una aproximación útil. *(PMID 41114449 · PBM-14)*

128. Q128 — Respuesta: *B*. Isquemia, lactato elevado o SvO2 baja indican mala tolerancia. *(PMID 41114449 · PBM-14)*

129. Q129 — Respuesta: *A*. El TP/TTPa de rutina tiene bajo rendimiento; mejor anamnesis estructurada. *(PMID 27369959 · PBM-15)*

130. Q130 — Respuesta: *A*. Siete preguntas dicotómicas (Hematoma, hEmorragia, Menorragia, Surgery, Tooth, Obstetrics, Parents). *(PMID 27369959 · PBM-15)*

131. Q131 — Respuesta: *D*. Score ≥ 2: especificidad 98,6% y sensibilidad 89,5% para precisar precauciones. *(PMID 27369959 · PBM-15)*

132. Q132 — Respuesta: *D*. Las pruebas estándar tienen sensibilidad ≈ 26%, muy inferior a HEMSTOP. *(PMID 27369959 · PBM-15)*

133. Q133 — Respuesta: *A*. Por eso el cribado por pruebas básicas falla y se prefiere la anamnesis. *(PMID 27369959 · PBM-15)*

134. Q134 — Respuesta: *B*. M = Menorragia (reglas abundantes). *(PMID 27369959 · PBM-15)*

135. Q135 — Respuesta: *C*. Revisar antiagregantes/anticoagulantes (PBM-16) y apoyo de hematología. *(PMID 36855941 · PBM-15)*

136. Q136 — Respuesta: *D*. Evita pruebas inútiles al ser muy improbable un trastorno oculto. *(PMID 27369959 · PBM-15)*

137. Q137 — Respuesta: *A*. Suspender reduce sangrado pero expone a trombosis; mantener, al revés. *(PMID 36855941 · PBM-16)*

138. Q138 — Respuesta: *A*. Fármaco (vida media) × riesgo trombótico del paciente × riesgo hemorrágico del procedimiento. *(PMID 36855941 · PBM-16)*

139. Q139 — Respuesta: *D*. No puente: no inferior para tromboembolismo (0,4% vs 0,3%) y menos hemorragia (RR 0,41). *(PMID 26095867 · PBM-16)*

140. Q140 — Respuesta: *A*. A menudo puede mantenerse según el procedimiento. *(PMID 36855941 · PBM-16)*

141. Q141 — Respuesta: *D*. CCP con vitamina K, más rápido y eficaz que el plasma. *(PMID 36855941 · PBM-16)*

142. Q142 — Respuesta: *A*. Vida media corta; manejo predecible y habitualmente sin puente. *(PMID 36855941 · PBM-16)*

143. Q143 — Respuesta: *C*. Posponer hasta superar el riesgo de trombosis del stent; decisión multidisciplinar. *(PMID 36855941 · PBM-16)*

144. Q144 — Respuesta: *B*. Se reserva para alto riesgo trombótico seleccionado. *(PMID 26095867 · PBM-16)*

145. Q145 — Respuesta: *A*. Suelen suspenderse por su mayor efecto hemorrágico. *(PMID 36855941 · PBM-16)*

146. Q146 — Respuesta: *B*. Reiniciar cuando el riesgo de sangrado sea aceptable, de forma escalonada y coordinada. *(PMID 36855941 · PBM-16)*

147. Q147 — Respuesta: *C*. La von Willebrand es la más común, a menudo infradiagnosticada. *(PMID 25100430 · PBM-17)*

148. Q148 — Respuesta: *C*. Plan perioperatorio anticipado con objetivos de factor y cobertura. *(PMID 25100430 · PBM-17)*

149. Q149 — Respuesta: *A*. No transfundir plasma por una analítica alterada sin sangrado. *(PMID 29527654 · PBM-17)*

150. Q150 — Respuesta: *B*. Hemofilia A = factor VIII; B = factor IX. *(PMID 25100430 · PBM-17)*

151. Q151 — Respuesta: *D*. Se dirigen a la causa y al déficit demostrado. *(PMID 36855941 · PBM-17)*

152. Q152 — Respuesta: *C*. Anticipar y planificar con hematología. *(PMID 25100430 · PBM-17)*

153. Q153 — Respuesta: *A*. Desmopresina (en respondedores) o concentrado de FvW/FVIII. *(PMID 25100430 · PBM-17)*

154. Q154 — Respuesta: *C*. De ahí el valor del cribado por anamnesis (HEMSTOP). *(PMID 27369959 · PBM-17)*

155. Q155 — Respuesta: *A*. Su indicación más clara es la reversión urgente de los AVK. *(PMID 36855941 · PBM-18)*

156. Q156 — Respuesta: *D*. Reponer si < 1,5 g/l o déficit funcional en viscoelástica. *(PMID 36855941 · PBM-18)*

157. Q157 — Respuesta: *C*. Rescate off-label tras optimizar todo; se asocia a eventos trombóticos. *(PMID 36855941 · PBM-18)*

158. Q158 — Respuesta: *B*. Libera FvW y FVIII; útil en vW tipo 1 respondedora y disfunción plaquetaria. *(PMID 36855941 · PBM-18)*

159. Q159 — Respuesta: *B*. Vigilar hiponatremia, sobre todo con dosis repetidas. *(PMID 36855941 · PBM-18)*

160. Q160 — Respuesta: *C*. No sustituye el control quirúrgico ni la corrección de calcio/temperatura/pH/fibrinógeno. *(PMID 36855941 · PBM-18)*

161. Q161 — Respuesta: *C*. Uso dirigido al déficit, no como gesto genérico. *(PMID 36855941 · PBM-18)*

162. Q162 — Respuesta: *B*. El CCP es más rápido y eficaz que el plasma para revertir AVK. *(PMID 36855941 · PBM-18)*

163. Q163 — Respuesta: *A*. El concentrado de fibrinógeno ha desplazado al crioprecipitado en muchos países europeos. *(PMID 29527654 · PBM-18)*

164. Q164 — Respuesta: *B*. Pilar 1: optimizar la masa eritrocitaria (anemia, hierro, EPO). *(PMID 30860564 · P-QR-01)*

165. Q165 — Respuesta: *B*. Pilar 2: minimizar la pérdida (hemostasia, TXA, viscoelástica, recuperador, MABL). *(PMID 30860564 · P-QR-01)*

166. Q166 — Respuesta: *C*. Pilar 3: tolerancia a la anemia y umbrales restrictivos. *(PMID 30860564 · P-QR-01)*

167. Q167 — Respuesta: *D*. Optimiza la masa, minimiza la pérdida y tolera la anemia. *(PMID 30860564 · P-QR-01)*

168. Q168 — Respuesta: *B*. Criterios restrictivos y transfusión de una unidad cada vez con reevaluación. *(PMID 41114449 · P-QR-01)*

169. Q169 — Respuesta: *D*. El eje de hemostasia clínica es el Módulo 5 (PBM-15 a 18). *(PMID 36855941 · P-QR-01)*

170. Q170 — Respuesta: *A*. Restrictivo < 7 g/dl en estable/crítico/séptico estable. *(PMID 37824153 · P-QR-02)*

171. Q171 — Respuesta: *A*. 8 g/dl en ortopedia o ECV crónica. *(PMID 37824153 · P-QR-02)*

172. Q172 — Respuesta: *D*. Excepción del SCA: liberal ≈ 10 g/dl (en contra de restrictivo). *(PMID 39341492 · P-QR-02)*

173. Q173 — Respuesta: *B*. < 50 ×10⁹/l para cirugía mayor no neuroaxial o RI de alto riesgo. *(PMID 40440268 · P-QR-02)*

174. Q174 — Respuesta: *A*. PL 50→20 y CVC 20→10 ×10⁹/l. *(PMID 40440268 · P-QR-02)*

175. Q175 — Respuesta: *C*. 10-15 ml/kg, solo con coagulopatía y sangrado. *(PMID 29527654 · P-QR-02)*

176. Q176 — Respuesta: *A*. Rige el protocolo (PBM-13), no los umbrales profilácticos. *(PMID 25647203 · P-QR-02)*

177. Q177 — Respuesta: *B*. Hasta 1 unidad de aféresis; dosis mayores no aportan más eficacia. *(PMID 40440268 · P-QR-02)*

178. Q178 — Respuesta: *C*. La administración precoz (< 3 h) es el factor común de eficacia. *(PMID 28456509 · P-QR-03)*

179. Q179 — Respuesta: *C*. 1 g IV, repetible si persiste el sangrado. *(PMID 28456509 · P-QR-03)*

180. Q180 — Respuesta: *C*. ATACAS: ligero aumento de convulsiones a dosis altas. *(PMID 27774838 · P-QR-03)*

181. Q181 — Respuesta: *B*. CRASH-3: efecto limitado en TCE grave establecido. *(PMID 31623894 · P-QR-03)*

182. Q182 — Respuesta: *D*. 1 g en 10 min + 1 g en 8 h, iniciar < 3 h. *(PMID 20554319 · P-QR-03)*

183. Q183 — Respuesta: *C*. Reduce la muerte por hemorragia (CRASH-2, WOMAN). *(PMID 20554319 · P-QR-03)*

184. Q184 — Respuesta: *A*. Reduce hemorragia, transfusión y reoperación por sangrado. *(PMID 27774838 · P-QR-03)*

185. Q185 — Respuesta: *B*. Estima la pérdida admisible para planificar, no para disparar transfusión. *(PMID 6829965 · P-QR-04)*

186. Q186 — Respuesta: *B*. VSE se calcula a partir de talla y peso (y sexo). *(PMID 21936146 · P-QR-04)*

187. Q187 — Respuesta: *D*. Hto medio = (Hto_ini + Hto_diana)/2. *(PMID 6829965 · P-QR-04)*

188. Q188 — Respuesta: *A*. La transfusión se decide por el umbral (P-QR-02), el sangrado y la clínica. *(PMID 41114449 · P-QR-04)*

189. Q189 — Respuesta: *B*. Optimizar Hb previa, activar ahorro de sangre y planificar disponibilidad. *(PMID 37681564 · P-QR-04)*

190. Q190 — Respuesta: *D*. ≈ 65 ml/kg en la mujer (70 ml/kg en el varón). *(PMID 21936146 · P-QR-04)*

191. Q191 — Respuesta: *B*. Traduce el riesgo en una decisión anticipada que integra los pilares. *(PMID 6829965 · P-QR-04)*

192. Q192 — Respuesta: *A*. Fármaco × riesgo trombótico × riesgo hemorrágico. *(PMID 36855941 · P-QR-05)*

193. Q193 — Respuesta: *D*. El marco da la decisión; los tiempos exactos, del protocolo local y la ficha técnica. *(PMID 36855941 · P-QR-05)*

194. Q194 — Respuesta: *C*. BRIDGE: el puente sistemático añade sangrado; reservarlo a alto riesgo seleccionado. *(PMID 26095867 · P-QR-05)*

195. Q195 — Respuesta: *D*. CCP con vitamina K; reversión y rescate en PBM-18. *(PMID 36855941 · P-QR-05)*

196. Q196 — Respuesta: *D*. Más hemorragia mayor con puente (RR 0,41 a favor de no puente). *(PMID 26095867 · P-QR-05)*

197. Q197 — Respuesta: *A*. Reiniciar de forma escalonada y coordinada entre equipos. *(PMID 36855941 · P-QR-05)*

198. Q198 — Respuesta: *C*. La tolerancia compensatoria permite equivalencia o beneficio con menos transfusión. *(PMID 41114449 · PBM-12)*

199. Q199 — Respuesta: *D*. Crioprecipitado: fibrinógeno, FVIII, FXIII, factor de von Willebrand y fibronectina. *(PMID 36855941 · PBM-02)*

200. Q200 — Respuesta: *C*. La activación precoz evita el retraso logístico y salva vidas. *(PMID 36855941 · PBM-13)*

Cuestionario de la Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - 200 preguntas - 2026. Preguntas y soluciones fundamentadas en los 23 documentos de la serie, verificadas contra PubMed (CAUSA / SACYL). Material docente; no sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.
Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*